# NEOPLASIAS DEL PÁNCREAS

DR. MOISÉS CUKIER

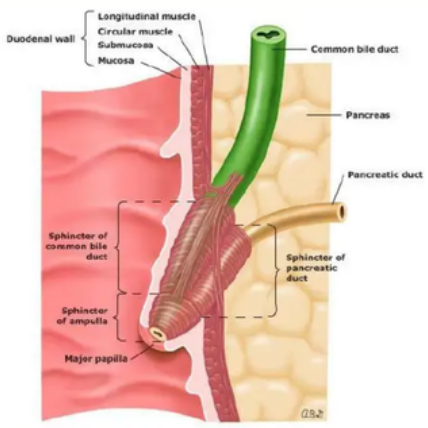
**TUMORES EXÓCRINOS**
- Neoplasias quísticas (<1%) y adenocarcinoma de páncreas (90%, el más frecuente).
- Adenocarcinoma: 4.ª causa de mortalidad por cáncer; sin factores de riesgo concluyentes, se sospecha un componente hereditario.

**TUMORES ENDOCRINOS**
- Neuroendocrinos no funcionantes (5%) y funcionantes (1–2%, ej. insulinoma).

**IPMN**
- Neoplasia mucinosa papilar intraductal: generalmente asintomática, hallazgo incidental.
- Tipos main-duct y side-branch; riesgo de malignidad del 1% al 20% (guías de Sendai).

**CARCINOMA PERIAMPULAR**
- Incluye tumores de cabeza de páncreas, duodeno (2.ª porción), colangiocarcinoma distal y ámpula de Vater.

**ADENOCARCINOMA DE CUERPO Y COLA**
- 10–20% de los casos; pocos síntomas iniciales, se diagnostica avanzado; el dolor abdominal es más frecuente.




**SEGUIMIENTO POSOPERATORIO**
- Ca 19-9 e imágenes periódicas tras la resección.
- La recurrencia es frecuente incluso tras cirugía curativa: papel de la quimioterapia adyuvante.

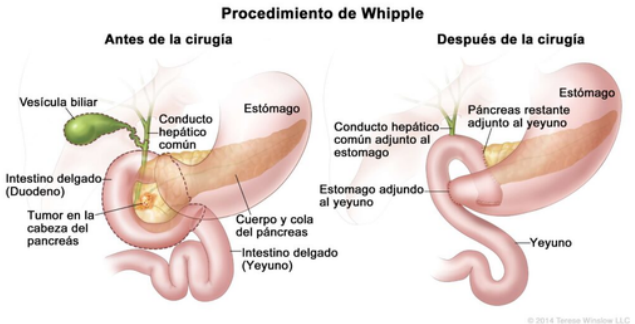
**CLÍNICA**
- Debilidad, pérdida de peso, ictericia obstructiva, dolor abdominal leve o ausente.
- Examen físico: signo de Courvoisier (vesícula palpable e indolora) y síndrome de Trousseau (tromboflebitis migratoria).

**ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS**
- Laboratorio: hemograma, pruebas hepáticas y bilirrubinas, Ca 19-9.
- Imágenes: ultrasonido hepatopancreático, TC multicorte trifásica (diagnóstico y resecabilidad), ultrasonido endoscópico, colangio-RM o CPRE.

**TUMOR RESECABLE**
- Pancreatoduodenectomía (Whipple) o resección de páncreas según la localización.

**TUMOR BORDERLINE**
- Neoadyuvancia (quimio/radioterapia) y luego Whipple con resección vascular.

**TUMOR IRRESECABLE**
- Paliativo: derivación biliar y/o digestiva y quimioterapia paliativa.




**INSULINOMA**
- Tumor neuroendocrino funcionante más frecuente; hipoglucemia con tríada de Whipple (síntomas, glucosa baja documentada, mejoría con glucosa).

**GASTRINOMA**
- Zollinger-Ellison: hipersecreción ácida y úlceras pépticas múltiples o refractarias.

# NEOPLASIAS DEL PÁNCREAS

DR. MOISÉS CUKIER

**FACTORES DE RIESGO DEL ADENOCARCINOMA**

- Edad avanzada, historia familiar y mutaciones genéticas (p. ej., BRCA2).
- Tabaquismo, pancreatitis crónica, diabetes y obesidad.

**SÍNTOMAS DEL ADENOCARCINOMA**

- Dolor abdominal o de espalda, ictericia, pérdida de peso inexplicada y de apetito, fatiga y depresión.

**DIAGNÓSTICO DEL ADENOCARCINOMA**

- Imágenes: TC, RM y ultrasonido endoscópico (EUS).
- Laboratorio: marcador tumoral CA 19-9.
- Biopsia: por EUS o laparoscopia.

**PROCEDIMIENTO DE WHIPPLE**

- Pancreatoduodenectomía para tumores de la cabeza del páncreas.

**PANCREATECTOMÍA DISTAL**

- Para tumores del cuerpo o la cola del páncreas.

**QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA**

- Quimioterapia neoadyuvante (antes) o adyuvante (después de la cirugía).
- La radioterapia suele combinarse con la quimioterapia.

**TERAPIAS DIRIGIDAS E INMUNOTERAPIA**

- Opciones emergentes en casos avanzados o metastásicos.

**TUMORES DE CÉLULAS DE LOS ISLOTES**

- Menos comunes; benignos o malignos: insulinomas, gastrinomas, glucagonomas, somatostatinomas y VIPomas.
- Síntomas según la hormona: hipoglucemia (insulinoma), úlceras (gastrinoma), diabetes (glucagonoma).

**DIAGNÓSTICO DE LOS TUMORES ENDOCRINOS**

- TC, RM y EUS; niveles hormonales específicos en sangre; biopsia.

**TRATAMIENTO DE LOS TUMORES ENDOCRINOS**

- Cirugía: principal tratamiento curativo.
- Medicamentos para controlar la producción hormonal; quimioterapia y terapias dirigidas en casos malignos o metastásicos.

**DETECCIÓN TEMPRANA**

- Por su ubicación profunda y síntomas inespecíficos, suele diagnosticarse en etapas avanzadas; se desarrollan nuevas técnicas y marcadores.

**PREVENCIÓN**

- Evitar el tabaco, mantener un peso saludable, dieta rica en frutas, verduras y granos integrales, y limitar el alcohol.

**PRONÓSTICO**

- Depende del tipo, la ubicación y el estadio; el adenocarcinoma tiene pronóstico desfavorable por su agresividad y diagnóstico tardío.

